

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázka 126

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 67–71

126 — Léčiva používaná pro místní účinek na kůži a sliznicích (+ dezinficiencia)

Kostra: typy dermatologické léčby → **na čem závisí zevní účinek a průnik** → léčivé formy → **externa podle účinku** → hlavní léčiva → ⚠️ **koncentrační řady** → oficiální přípravky → **dezinficiencia** × antiseptika

Léčba v dermatologii: zevní (lokální) · celková (systémová) · fyzikální (chirurgická, fototerapie, kryoterapie)

⚠️ Úspěch závisí na správné diagnóze, fázi choroby a koncentraci zevního léku.

Zevní léčba — na čem stojí

Cílem je účinek v místě nálezu bez nutnosti systémového podání → nedojde k systémové nežádoucí reakci.

Efekt závisí na účinné látce, vehikulu a způsobu aplikace. ⚠️ Absorpci ovlivňuje tloušťka rohové vrstvy a integrity kůže, koncentrace léku a stav cévního systému v kóru.

Průnik rohovou vrstvou: transepidermálně (trans- nebo intercelulárně) × transadnexálně (vývody žláz)

Složení zevního léku: účinná látka · vehikulum/baze (vazelína) · pomocné látky (makrogol, glycerol, propylenglykol)

Lékové formy

Tekuté: roztoky (voda nebo líh) — ⚠️ působí povrchně, na mokvavé rány · kolodia s elastickou hmotou — ⚠️ keratolytická léčba bradavic · koupele

Pevné: obklady — vzdušné (vysychavé) × zapařovací (neprodyšné) · zasypy (oxid zinečnatý a talek) — ⚠️ ne na mokvajících dermatózách · tekuté pudry — nutno protřepat · gely

Mast'ové: oleje · masti (vazelína, včelí vosk) · krémy — ⚠️ o/v = denní, v/o = noční · pasty — mast'ový základ s práškovou hmotou

Externa podle účinku (stejně dělení jako u dermatologik v otázce 112): antimikrobiální · antiseptika · antiseboroika · antihidrotika · antipruriginóza · cytostatika · fotoprotektiva · keratolytika × keratoplastika · adstringencia

Hlavní léčiva

Kortikosteroidy — vazokonstrikční, protizánětlivý, antiproliferativní, imunomodulační účinek. ⚠️ Dostupnost se zlepšuje esterifikací, aktivita halogenizací.

Indikace: solární dermatitida, **atopický ekzém**, menší popálenina, **lupus erythematoses**. ⚠ **KI:** primárně infekční onemocnění · rány, akné · laktace, novorozenci. **NÚ:** atrofie kůže, strie, akneformní erupce, purpura, zvýšený růst ochlupení.

Kalcineurinové blokátory — imunomodulační externa, ⚠ **selektivně blokují tvorbu prozánětlivých cytokinů**; především atopický ekzém

Analoga vitaminu D — ⚠ **zastavují proliferaci keratinocytů** → psoriáza

Modifikátory imunitní odpovědi — modulace tvorby cytokinů, **virová a nádorová kožní onemocnění**

Glycerol 85 % — váže vodu a snižuje vysychání

⚠ **Koncentrační řady — nejděležitější část otázky**

Účinek obou látek závisí na koncentraci — přesně ten typ detailu, na který se ptají.

Kyselina salicylová: 1–2 % antiseptický, **keratoplastický** · 3–5 % antipruriginózní, **fungistatický**, antihydrotický · 5–10 % ⚠ **keratolytický** · 40–60 % ⚠ **leptavý** — v koloidu k odstranění bradavic

⚠ **Snadno se resorbuje** — při rozsáhlé aplikaci hrozí systémová toxicita — a zvyšuje průnik současně aplikovaných látek.

Močovina (urea): do 10 % hydratační · 10–20 % antibakteriální · nad 20 % antipruriginózní · 40–50 % ⚠ **keratolytický**

⚠ **Netoxická, nedráždivá, nevyvolává alergie.**

Klíč: u obou platí čím vyšší koncentrace, tím agresivnější účinek — od hydratace přes keratolýzu až k leptání.

Oficiální přípravky — fixní kombinace

Jarischův roztok — kyselina boritá, glycerol → antipruriginózní, keratoplastický, hydratační

Chlumského roztok — kafr, fenol, ethanol → antiseptikum

Novikovův roztok — brilantová zeleň, tanin, ethanol → ⚠ **tekutý obvaz**, antiseptický

⚠ **Dezinficiencia × antiseptika — rozdíl, na kterém otázka stojí**

	Dezinficiencia	Antiseptika
Kde působí	⚠ ve vnějším prostředí — na neživých předmětech, plochách, nástrojích, v infekčním materiálu	⚠ v prostředí živých tkání — kůže, rána, sliznice
Cíl	usmrcení mikroorganismů	zneškodnění (inhibice růstu)
Podmínka	⚠ nejvyšším stupněm dezinfekce je sterilizace	⚠ v koncentracích, které nepoškodí zdravé tkáně
Použití		příprava operačního pole, před injekcí, ošetření ran

Nejčastěji používaná antiseptika: ethanol 60–70 %, jodofory, chlorhexidin

Dělení podle chemické struktury:

Alkoholy — ⚠ působí na bakteriální membrány a denaturují bílkoviny: ethanol 60–70 %, isopropanol 70 % · **fenoly** — denaturace bílkovin, **oxidační účinky**: chlorhexidin · **aldehydy** — denaturace bílkovin: formaldehyd